Análisis normativo y población para la construcción de la nota técnica

Breve descripción:

El componente aborda el análisis de la población objeto, sus necesidades y características, a partir de fuentes de información del sector salud. Asimismo, presenta los fundamentos normativos, epidemiológicos y metodológicos relacionados con la nota técnica y su aplicación en los procesos de contratación de servicios y tecnologías en salud.

Octubre 2026

Tabla de contenido

Introducción 4

1. Caracterización de la población objeto 7

1.1. Concepto y contexto de la caracterización poblacional 7

1.2. Regímenes de afiliación 8

1.3. Determinantes de la población 10

1.4. Necesidades de la población objeto 13

1.5. Población objeto total y población susceptible 15

1.6. Parámetros epidemiológicos 18

1.7. Identificación y codificación de servicios y tecnologías 20

2. Análisis de la información en salud 22

2.1. Fuentes de información del sector salud 23

2.2. Frecuencia de uso de servicios y tecnologías 27

2.3. Análisis de la oferta y la demanda de servicios 29

2.4. Validación de los soportes de atención 32

3. Fundamentos de la contratación en salud 35

3.1. Marco normativo aplicable a los acuerdos de voluntades 36

3.2. Modalidades de pago 38

3.3. Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) 42

4. Calidad y atención en el contexto de la contratación en salud 45

4.1. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud 47

4.2. Habilitación de servicios de salud 49

4.3. Gestión del riesgo y seguridad del paciente 50

4.4. Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) 53

5. Manuales tarifarios y glosas 56

5.1. Tipos de tarifas 57

5.2. Lineamientos normativos de los manuales tarifarios 59

5.3. Glosas en la contratación de servicios de salud 62

6. Elementos generales de la nota técnica 65

6.1. Características y elementos 66

6.2. Servicios, tecnologías y frecuencias de uso 69

6.3. Riesgo primario y riesgo técnico 71

Síntesis 75

Glosario 77

Referencias bibliográficas 79

Créditos 82

Introducción

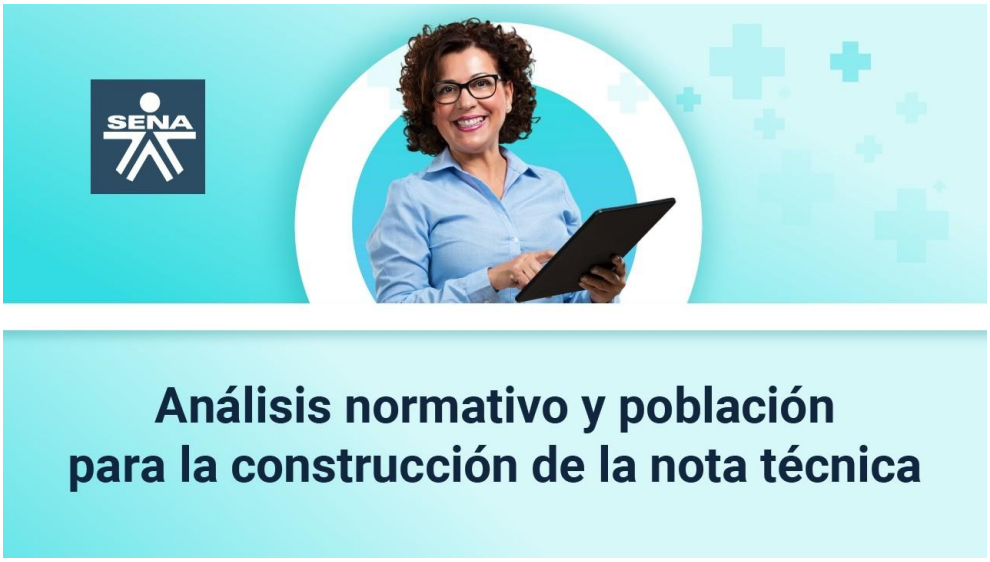
La nota técnica constituye un instrumento relacionado con la planeación, el seguimiento y la gestión de los acuerdos de voluntades entre los actores que participan en la prestación de servicios y tecnologías en salud. Su construcción requiere integrar información sobre la población objeto, sus necesidades, los servicios requeridos, las frecuencias de uso, los riesgos en salud y las condiciones establecidas en el marco normativo aplicable.

El análisis de las características de la población permite identificar necesidades y comportamientos relacionados con la utilización de los servicios de salud. Para ello, se consideran fuentes de información del sector, parámetros epidemiológicos y demográficos, así como elementos relacionados con la oferta y la demanda de servicios. Esta información constituye un insumo para establecer proyecciones y sustentar técnicamente los servicios y tecnologías que hacen parte de los acuerdos de voluntades.

En este contexto, el componente aborda los fundamentos necesarios para comprender la caracterización de la población, el análisis de información en salud, los principales lineamientos normativos relacionados con la contratación y las generalidades de la nota técnica. El desarrollo de estos contenidos proporciona las bases para interpretar la información requerida en su construcción y comprender su importancia como herramienta de planeación y seguimiento en los procesos de contratación en salud.

Para complementar la comprensión de los temas abordados, se recomienda acceder al siguiente video:

Video 1. Análisis normativo y población para la construcción de la nota técnica



Enlace de reproducción del video

Transcripción del video. Análisis normativo y población para la construcción de la nota técnica
Durante la planeación de un acuerdo de voluntades en salud, un equipo se reunió para proyectar los servicios que serían necesarios durante el periodo de contratación. Tenían información sobre la población, sus necesidades y los servicios utilizados en años anteriores.

Transcripción del video. Análisis normativo y población para la construcción de la nota técnica
Sin embargo, surgió una pregunta aparentemente sencilla: ¿cómo convertir toda esa información en una proyección técnica que permitiera sustentar las decisiones del acuerdo? Al revisar los datos, encontraron que no bastaba con saber cuántas personas requerían atención. Era necesario reconocer qué servicios y tecnologías podían utilizar, con qué frecuencia, bajo qué condiciones y cuáles eran los recursos asociados. También comprendieron que la información histórica debía analizarse con cuidado. Un cambio en la población, en la oferta de servicios o en las condiciones de atención podía modificar las frecuencias esperadas y, por tanto, las proyecciones realizadas. A medida que organizaban la información, la nota técnica comenzó a tomar forma. Ya no se trataba solamente de reunir cifras, sino de relacionar población, necesidades, utilización, costos y riesgos para sustentar técnicamente las condiciones del acuerdo. La experiencia permitió comprender que una nota técnica no surge de un único dato. Es el resultado de integrar información, analizarla y convertirla en elementos que apoyen la planeación y el seguimiento de la atención en salud.

1. Caracterización de la población objeto

La caracterización de la población objeto constituye un punto de partida para la construcción de la nota técnica, debido a que permite identificar las características, condiciones y necesidades de las personas que hacen parte del ámbito de atención definido en un acuerdo de voluntades. Este proceso requiere analizar información demográfica, epidemiológica y territorial, entre otros aspectos relevantes para establecer la población que puede requerir los servicios y tecnologías en salud.

El análisis de esta información permite diferenciar la población objeto total de la población susceptible, así como reconocer factores que pueden modificar las necesidades de atención y la utilización de los servicios. Para ello, se consideran fuentes de información y parámetros que contribuyen a sustentar las estimaciones utilizadas en la nota técnica.

De esta manera, la caracterización poblacional proporciona elementos para comprender a quiénes se dirige la atención, cuáles son sus principales necesidades y qué condiciones deben considerarse para proyectar los servicios y tecnologías requeridos.

1.1. Concepto y contexto de la caracterización poblacional

La caracterización poblacional es un proceso de análisis que permite identificar las condiciones de salud, características y particularidades de una población determinada. Su desarrollo considera información demográfica, epidemiológica, territorial y social, con el propósito de reconocer riesgos, necesidades y grupos que requieren atención específica.

En el contexto de la nota técnica, la caracterización de la población constituye un insumo para establecer las necesidades de servicios y tecnologías en salud y determinar las poblaciones a las que estos pueden estar dirigidos. Para ello, se requiere analizar información proveniente de diferentes fuentes y considerar las condiciones particulares del territorio y de la población objeto.

La Resolución 100 de 2024 reorganizó el proceso de planeación integral para la salud y estableció orientaciones para el análisis de las condiciones de salud de la población a cargo de las entidades responsables, con desagregación territorial. En este contexto, el análisis poblacional se articula con el Análisis de Situación de Salud (ASIS) y constituye un insumo para la planeación de las intervenciones en salud.

Por tanto, la caracterización poblacional no debe entenderse como un dato único o estático. Su análisis debe responder al propósito del acuerdo de voluntades y a las características de la población que requiere los servicios o tecnologías en salud.

1.2. Regímenes de afiliación

La población objeto de un acuerdo de voluntades puede estar conformada por personas pertenecientes a diferentes regímenes de afiliación del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Identificar esta condición permite delimitar las características de la población que será considerada en el análisis y relacionarla con sus necesidades de atención en salud.

En el contexto colombiano, el documento plantea principalmente los siguientes regímenes:

Tabla 1. Regímenes de afiliación y su relación con la caracterización poblacional

Régimen	**Características generales**	**Relación con la caracterización de la población**
Contributivo	Comprende a las personas con capacidad de pago que realizan aportes al sistema, de acuerdo con su condición de afiliación.	Permite identificar una población con características de afiliación y condiciones socioeconómicas que pueden considerarse en el análisis.
Subsidiado	Está dirigido a la población que, de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas, requiere el acceso a los servicios de salud mediante el mecanismo de subsidio.	Facilita la identificación de poblaciones con características sociales y económicas particulares y sus posibles necesidades de atención.
Regímenes especiales y de excepción	Corresponden a grupos de población que cuentan con condiciones particulares de afiliación y cobertura dentro del sistema.	Su identificación permite diferenciar las poblaciones que presentan condiciones específicas de afiliación frente a los demás regímenes.

La identificación del régimen de afiliación constituye, por tanto, un elemento de la caracterización poblacional. Su análisis, junto con variables demográficas, epidemiológicas, sociales, económicas y territoriales, contribuye a establecer las características de la población objeto y a sustentar el análisis de sus necesidades de servicios y tecnologías en salud.

1.3. Determinantes de la población

La pertenencia a un régimen de afiliación constituye solamente uno de los elementos que pueden considerarse en la caracterización de la población. Las condiciones en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen también pueden influir en sus condiciones de salud y en las posibilidades de acceder y utilizar los servicios de salud. Estas condiciones son reconocidas como determinantes sociales de la salud.

En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social aborda los determinantes sociales de la salud mediante factores estructurales e intermedios. Entre ellos se encuentran aspectos relacionados con el contexto socioeconómico y político, los ingresos, la educación, la ocupación, las condiciones de vivienda y trabajo, el entorno, las redes de apoyo, los factores biológicos y conductuales y el acceso a los servicios de salud.

Estos factores pueden generar diferencias en las necesidades de atención y en la utilización de servicios y tecnologías. Por ejemplo, una población ubicada en una zona rural dispersa puede presentar condiciones de acceso diferentes a las de una población urbana, debido a factores como la distancia, la disponibilidad de talento humano, la

oferta de servicios, las condiciones de transporte o la posibilidad de utilizar modalidades de atención a distancia.

Por esta razón, la caracterización utilizada como insumo para la nota técnica debe considerar las particularidades de la población y del territorio. El Análisis de Situación de Salud (ASIS) incorpora información relacionada con las condiciones sociales, económicas y de calidad de vida desde el enfoque de determinantes sociales, además de elementos asociados con la situación de salud, las necesidades y las respuestas existentes en el territorio.

En este sentido, el análisis de los determinantes complementa la información sobre afiliación, características demográficas y condiciones epidemiológicas, y permite contar con una perspectiva más amplia de los factores que pueden relacionarse con las necesidades de atención y la utilización de los servicios y tecnologías en salud. Entre estos aspectos se encuentran los siguientes:

Tabla 2. Aspectos de la población que pueden considerarse en la caracterización

Aspecto	**Elementos que pueden analizarse**	**Relación con la nota técnica**
Afiliación	Régimen contributivo, subsidiado y esquemas especiales o de excepción.	Permite delimitar y caracterizar la población objeto del análisis.
Demografía	Edad, sexo, distribución territorial y composición de la población.	Contribuye a identificar diferencias en las necesidades y en la utilización de servicios.

Aspecto	Elementos que pueden analizarse	Relación con la nota técnica
Condiciones epidemiológicas	Morbilidad, mortalidad, incidencia y prevalencia.	Permiten identificar riesgos y necesidades de atención.
Condiciones socioeconómicas	Ingresos, educación, ocupación y condiciones de vida.	Pueden influir en el estado de salud y en las posibilidades de acceso.
Características territoriales	Zona urbana o rural, dispersión geográfica y disponibilidad de servicios.	Pueden modificar la forma, oportunidad y disponibilidad de los servicios.
Acceso a servicios	Disponibilidad de talento humano, infraestructura, transporte y modalidades de atención.	Permite considerar condiciones que pueden afectar la utilización de servicios y tecnologías.

En la construcción de la nota técnica, esta información debe relacionarse con las características específicas de la población objeto y con el propósito del acuerdo de voluntades, de manera que contribuya a sustentar las estimaciones y proyecciones requeridas para los servicios y tecnologías en salud.

1.4. Necesidades de la población objeto

Las necesidades de salud de una población se relacionan con las condiciones que requieren atención para mantener, recuperar o mejorar su estado de salud. Su identificación requiere analizar las características de la población, sus condiciones epidemiológicas, los riesgos presentes y las particularidades del territorio. Por esta razón, la necesidad de atención no debe establecerse únicamente a partir de los servicios que la población solicita o utiliza.

En este contexto, es importante diferenciar los conceptos de necesidad, demanda y riesgo, debido a que cada uno aporta información diferente para el análisis de la población objeto:

- **Necesidad**: corresponde a los servicios y tecnologías que una población requiere de acuerdo con sus condiciones de salud, riesgos y características epidemiológicas. Su identificación permite establecer las atenciones que pueden requerirse para responder a las condiciones de salud de la población objeto.
- **Demanda**: corresponde a los servicios que la población solicita o utiliza efectivamente. Esta puede diferir de la necesidad debido a condiciones que facilitan o limitan el acceso a los servicios de salud. Por ello, la demanda observada no necesariamente representa la totalidad de las necesidades de la población.
- **Riesgo**: se relaciona con la probabilidad de ocurrencia de un evento en salud y sus posibles consecuencias. Su análisis permite considerar condiciones que pueden modificar las necesidades de atención y las proyecciones realizadas en la nota técnica.

El análisis de las necesidades requiere utilizar información epidemiológica y poblacional que permita aproximarse a las condiciones de salud de la población.

Para la construcción de la nota técnica, el reconocimiento de estas necesidades permite establecer los servicios y tecnologías que deben considerarse en el acuerdo de voluntades. El análisis puede abarcar las diferentes intervenciones requeridas de acuerdo con las condiciones de la población, desde acciones de promoción y mantenimiento de la salud hasta aquellas relacionadas con el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y demás atenciones que correspondan al objeto del acuerdo.

Por ejemplo, una población con una determinada condición de salud puede requerir actividades de educación, seguimiento y control, además de los servicios destinados al tratamiento de la enfermedad. De esta manera, el análisis de necesidades permite considerar las intervenciones requeridas de manera integral y no limitar la proyección únicamente a las atenciones que ya han sido utilizadas.

En la construcción de la nota técnica, las necesidades identificadas deben relacionarse con la población objeto, las condiciones epidemiológicas, los riesgos en salud y las características del territorio. Esta información constituye un insumo para sustentar la selección y proyección de los servicios y tecnologías que harán parte del acuerdo de voluntades.

1.5. Población objeto total y población susceptible

Una vez identificadas las necesidades de la población y los servicios y tecnologías relacionados con estas, es necesario determinar cuál es la población que será considerada en el acuerdo de voluntades. Para ello, se diferencian la población objeto total y la población susceptible, conceptos que permiten establecer el alcance de los servicios y tecnologías que serán proyectados en la nota técnica:

- **Población objeto total**: corresponde al universo de personas que se encuentra comprendido dentro del objeto del acuerdo de voluntades. Su tamaño depende de las condiciones y del alcance definido en dicho acuerdo y generalmente se expresa mediante un número absoluto.
- **Población susceptible**: corresponde al grupo de personas dentro de la población objeto total que, de acuerdo con sus características, condiciones de salud, riesgos o necesidades, puede requerir un servicio o tecnología específico. Por esta razón, la población susceptible puede variar de un servicio o tecnología a otro y no necesariamente corresponde al total de la población objeto.

La siguiente tabla sintetiza las principales diferencias entre ambos conceptos, considerando su alcance, los criterios para su delimitación y su relación con la proyección de los servicios y tecnologías en salud:

Tabla 3. Diferencias entre población objeto total y población susceptible

Aspecto	Población objeto total	Población susceptible
Definición	Universo de personas comprendido en el acuerdo de voluntades.	Parte de la población objeto que puede requerir un servicio o tecnología específico.
Alcance	Corresponde al conjunto general de personas definido para el acuerdo.	Se delimita de acuerdo con las características, condiciones de salud, riesgos o necesidades relacionadas con cada servicio o tecnología.
Expresión	Generalmente se expresa como un número absoluto.	Puede establecerse mediante proporciones, porcentajes, prevalencias, incidencias o tasas de uso, según la información disponible.
Aplicación	Permite establecer el universo sobre el cual se desarrolla el análisis.	Permite realizar estimaciones más específicas de utilización de los servicios y tecnologías.

Para establecer la población susceptible de cada servicio o tecnología, se deben considerar diferentes elementos:

- La población que requiere el servicio o tecnología, de acuerdo con las rutas integrales de atención en salud, las guías de práctica clínica o los consensos de expertos disponibles.
- Los parámetros epidemiológicos, como prevalencia, incidencia o tasa de uso, preferiblemente obtenidos de información correspondiente a la población y al territorio analizados.
- Las condiciones operativas y territoriales, entre ellas la distribución urbana o rural, el acceso a telemedicina y la disponibilidad de talento humano especializado.
- Los riesgos primarios o técnicos asociados con la población y con los servicios o tecnologías objeto del análisis.

Por ejemplo, si un acuerdo de voluntades comprende la atención de una población con una determinada condición de salud, no todas las personas incluidas en el acuerdo necesariamente requerirán los mismos servicios. La población susceptible de una consulta especializada puede ser diferente de la población que requiere actividades de promoción, seguimiento o control. Esta diferenciación permite realizar proyecciones de utilización más ajustadas a las características y necesidades de cada grupo.

En la construcción de la nota técnica, la diferenciación entre población objeto total y población susceptible permite relacionar el alcance del acuerdo de voluntades con las necesidades específicas de cada servicio o tecnología. De esta manera, las estimaciones pueden sustentarse en las características reales de la población y no únicamente en el número total de personas cubiertas.

1.6. Parámetros epidemiológicos

Los parámetros epidemiológicos permiten describir y analizar la ocurrencia de eventos y condiciones de salud en una población determinada. En la construcción de la nota técnica, estos parámetros aportan información para estimar la población susceptible y proyectar la utilización de los servicios y tecnologías de salud.

Entre los parámetros considerados se encuentran la incidencia, la prevalencia y la tasa de uso, cuya selección depende de las características de la población y del servicio o tecnología que se pretenda analizar:

- **Incidencia**: la incidencia se relaciona con la aparición de casos nuevos de una enfermedad o evento de salud en una población durante un periodo determinado. Este parámetro resulta útil para analizar eventos que se presentan por primera vez y estimar el comportamiento esperado de nuevos casos.

  En la nota técnica, la incidencia puede utilizarse cuando el servicio o tecnología está relacionado con la atención de eventos o condiciones cuya aparición durante un periodo sea relevante para establecer la población susceptible.
- **Prevalencia**: la prevalencia se refiere a la proporción de personas de una población que presenta una determinada enfermedad, condición o evento de salud en un momento o periodo específico. A diferencia de la incidencia, considera los casos existentes en la población analizada.

Este parámetro puede ser útil para establecer el tamaño de poblaciones que requieren seguimiento, control o atención de condiciones de salud ya presentes.

- **Tasa de uso**: la tasa de uso permite relacionar la utilización de un servicio o tecnología con una población determinada durante un periodo. Su análisis aporta información sobre el comportamiento observado de la utilización de los servicios y puede contribuir a establecer las frecuencias esperadas para la nota técnica.

  Para determinar los parámetros epidemiológicos asociados con las poblaciones definidas, pueden considerarse prevalencia, incidencia, tasas de uso, entre otros, y se recomienda priorizar fuentes correspondientes al territorio o al contexto poblacional analizado.

Los parámetros epidemiológicos no deben analizarse de manera aislada. Su utilidad depende de la población a la que se aplican, del servicio o tecnología objeto del análisis y de las fuentes utilizadas para obtener la información. Por ello, al establecer la población susceptible, es necesario seleccionar el parámetro que corresponda a la condición o servicio analizado y utilizar información que permita sustentar la estimación.

Las fuentes para establecer estos parámetros deben priorizar, en su orden, la caracterización poblacional o el ASIS del territorio, la caracterización poblacional nacional y otras fuentes locales, nacionales o internacionales disponibles, según corresponda.

En la construcción de la nota técnica, los parámetros epidemiológicos constituyen un insumo para relacionar las condiciones de salud de la población con la estimación de

la población susceptible y la frecuencia esperada de utilización de los servicios y tecnologías.

1.7. Identificación y codificación de servicios y tecnologías

Una vez caracterizada la población, identificadas sus necesidades y determinada la población susceptible, es necesario establecer con precisión los servicios y tecnologías que serán considerados en el acuerdo de voluntades. Para ello, estos deben identificarse mediante los códigos correspondientes a las tablas de referencia estandarizadas señaladas en el documento de Lineamientos de la Nota Técnica.

La codificación permite utilizar una denominación estandarizada de los servicios y tecnologías y facilita su seguimiento, facturación y reporte dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Por esta razón, la identificación no debe limitarse a una descripción en lenguaje libre, sino que debe corresponder al código oficial aplicable.

Entre las principales codificaciones mencionadas en el documento se encuentran:

- **Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS)**: permite identificar los procedimientos en salud mediante códigos estandarizados. La Resolución 2706 de 2025 establece la CUPS vigente y sus modificaciones, por lo que debe consultarse esta clasificación al momento de identificar y codificar los procedimientos incluidos en la nota técnica.
- **Código Único de Medicamentos (CUM) e Identificador Único de Medicamento (IUM)**: corresponden a los identificadores utilizados para los

medicamentos, de acuerdo con la información presentada en el documento y las referencias allí señaladas.

- **Dispositivos médicos e insumos**: el documento señala que, mientras no exista una codificación única definida para estos elementos, las partes que suscriben el acuerdo pueden establecer su identificación de manera conjunta.

Actualización de los códigos

Los códigos y las tablas de referencia pueden presentar modificaciones. Por ello, el documento recomienda verificar la información histórica frente a la clasificación vigente antes de elaborar el listado definitivo de servicios y tecnologías. En el caso de los procedimientos, debe consultarse la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS) vigente, de acuerdo con la normativa aplicable.

Esta verificación resulta relevante porque un código puede haber sido modificado, dividido o retirado de una clasificación posterior. En consecuencia, utilizar códigos desactualizados puede afectar la identificación de los servicios y tecnologías incluidos en la nota técnica y generar dificultades en los procesos posteriores de seguimiento y facturación.

En la construcción de la nota técnica, la identificación y codificación de los servicios y tecnologías debe realizarse a partir de las tablas y referencias vigentes, de manera que la información utilizada corresponda al objeto del acuerdo de voluntades y pueda ser reconocida de forma estandarizada por las partes.

2. Análisis de la información en salud

La construcción de una nota técnica requiere información que permita sustentar las estimaciones relacionadas con la población, las necesidades de atención, la utilización de los servicios y tecnologías en salud y las condiciones en las que se desarrolla la prestación. Por esta razón, el análisis de información constituye una etapa fundamental para transformar los datos disponibles en insumos que permitan realizar proyecciones acordes con las características de la población objeto.

Las fuentes de información del sector salud aportan datos desde diferentes perspectivas. Algunas permiten identificar la población y sus condiciones de afiliación; otras contienen información sobre las atenciones efectivamente realizadas, los eventos de interés en salud pública, las condiciones de salud o el comportamiento de determinadas enfermedades y grupos de riesgo. La integración de estas fuentes permite obtener una visión más completa de la población y reducir el riesgo de realizar estimaciones a partir de una única fuente de información.

A partir de la información disponible, es posible analizar el comportamiento histórico de los servicios y tecnologías utilizados, establecer frecuencias de uso y reconocer diferencias asociadas con las características de la población o con las condiciones operativas de la prestación. Este análisis constituye un insumo para proyectar las necesidades esperadas durante el periodo de vigencia del acuerdo de voluntades.

Asimismo, el análisis debe considerar la relación entre la oferta y la demanda de servicios de salud. La información sobre los servicios disponibles, la capacidad de prestación y las atenciones efectivamente realizadas permite identificar condiciones

que pueden influir en el comportamiento observado y que deben tenerse en cuenta al interpretar los datos utilizados para la construcción de la nota técnica.

2.1. Fuentes de información del sector salud

La construcción de la nota técnica requiere información que permita caracterizar la población objeto, identificar sus necesidades de atención, analizar las condiciones de salud y establecer el comportamiento de los servicios y tecnologías utilizados. Para ello, se dispone de diferentes fuentes de información del sector salud, cada una de las cuales aporta datos que pueden complementar el análisis.

Entre las principales fuentes se encuentran el Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO), el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), la Cuenta de Alto Costo (CAC) y la información relacionada con la caracterización poblacional y el Análisis de Situación de Salud (ASIS).

Cada fuente aporta información específica que contribuye a la caracterización de la población y al análisis de las necesidades, las condiciones de salud y la utilización de los servicios. A continuación, se describen sus principales aportes y su utilidad en la construcción de la nota técnica:

- **Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO)**: integra información proveniente de diferentes registros del sector salud y proporciona datos relacionados con la población, la afiliación, la prestación de servicios y las condiciones de salud. Su consulta permite disponer de información para caracterizar la población y apoyar el análisis requerido en

la construcción de la nota técnica. Para mayor información, consultar: https://www.sispro.gov.co/Pages/Home.aspx

- **Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS)**: contiene información relacionada con las atenciones realizadas a los usuarios de los servicios de salud. Su análisis permite identificar el comportamiento histórico de la prestación y establecer las frecuencias de utilización de los servicios y tecnologías. Para este propósito, resulta necesario contar con información consistente y depurada. Para mayor información, consultar: https://www.sispro.gov.co/central-financiamiento/Pages/facturacion-electronica.aspx
- **Base de Datos Única de Afiliados (BDUA)**: contiene información relacionada con la afiliación de las personas al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Permite identificar aspectos como la población afiliada y el régimen al que pertenece, información que contribuye a delimitar y caracterizar la población objeto del acuerdo de voluntades. Para mayor información, consultar: https://servicios.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA
- **Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA)**: proporciona información sobre eventos de interés en salud pública que son objeto de vigilancia. Estos datos pueden contribuir al análisis de las condiciones epidemiológicas de una población y a la identificación de situaciones que deben considerarse en la proyección de servicios y tecnologías en salud. Para mayor información, consultar: https://portalsivigila.ins.gov.co/Paginas/inicio.aspx

- **Cuenta de Alto Costo (CAC)**: genera información e indicadores relacionados con la gestión del riesgo de determinadas enfermedades crónicas y condiciones de alto costo. Esta información puede ser utilizada para analizar poblaciones que presentan condiciones específicas y establecer elementos relacionados con sus necesidades de atención. Para mayor información, consultar: https://cuentadealtocosto.org/
- **Caracterización poblacional y Análisis de Situación de Salud (ASIS)**: la caracterización poblacional aporta información sobre las condiciones de salud y las características demográficas, sociales, económicas y territoriales de una población. El Análisis de Situación de Salud (ASIS) integra información que permite reconocer las condiciones de salud, las necesidades y las particularidades de los territorios, constituyéndose en un insumo para la planeación de las intervenciones en salud. Para mayor información, consultar: https://www.minsalud.gov.co/salud/epidemiologia-demografia/Paginas/analisis-de-situacion-de-salud.aspx

Las diferentes fuentes de información aportan datos complementarios y su utilización depende del aspecto que se pretenda analizar. Por ejemplo, la información de afiliación permite delimitar la población objeto, mientras que los registros de prestación facilitan el análisis de los servicios utilizados y las fuentes epidemiológicas aportan información sobre las condiciones de salud y los riesgos de la población.

Por esta razón, la construcción de la nota técnica requiere analizar la información de manera articulada, considerando la población objeto, el periodo de análisis, las características del territorio y el propósito del acuerdo de voluntades. La integración de

las fuentes proporciona elementos para sustentar las estimaciones de utilización y las proyecciones de los servicios y tecnologías en salud. La siguiente tabla sintetiza las principales fuentes de información, los datos que aportan y su utilidad en este proceso:

Tabla 4. Principales fuentes de información para la construcción de la nota técnica

Fuente de información	Información que aporta	Utilidad en la nota técnica
SISPRO	Información integrada de diferentes registros del sector salud.	Apoyar el análisis de la población, las condiciones de salud y la prestación de servicios.
RIPS	Información de las atenciones realizadas a los usuarios.	Analizar la utilización histórica de servicios y tecnologías y establecer frecuencias de uso.
BDUA	Información relacionada con la afiliación al sistema de salud.	Delimitar y caracterizar la población objeto.
SIVIGILA	Información sobre eventos de interés en salud pública.	Identificar condiciones y eventos epidemiológicos relevantes para el análisis.
CAC	Información e indicadores sobre determinadas enfermedades crónicas y condiciones de alto costo.	Analizar poblaciones y condiciones específicas de riesgo.

Fuente de información	Información que aporta	Utilidad en la nota técnica
Caracterización poblacional y ASIS	Información sobre condiciones de salud, características poblacionales y territoriales.	Identificar necesidades, riesgos y particularidades de la población y el territorio.

2.2. Frecuencia de uso de servicios y tecnologías

Una vez identificada la población objeto y analizadas sus características y necesidades, es necesario establecer la frecuencia con la que se espera que utilice los servicios y tecnologías en salud incluidos en el acuerdo de voluntades. Esta información constituye un elemento fundamental para realizar las estimaciones requeridas en la nota técnica.

La frecuencia de uso corresponde a la cantidad de veces que un determinado servicio o tecnología puede ser utilizado por una población durante un periodo establecido. Su determinación requiere analizar información histórica de utilización y relacionarla con las características de la población objeto, las condiciones de salud y las particularidades de la prestación.

Para establecer las frecuencias de uso pueden considerarse los siguientes elementos:

- **Población objeto**: permite determinar el grupo sobre el cual se realizará la estimación.

- **Servicio o tecnología**: cada servicio o tecnología requiere establecer su propia frecuencia de utilización
- **Periodo de análisis**: permite determinar el comportamiento de la utilización durante un intervalo definido.
- **Información histórica**: los registros de utilización de periodos anteriores constituyen un insumo para identificar comportamientos y establecer estimaciones.
- **Características de la población**: las diferencias demográficas, epidemiológicas y territoriales pueden generar frecuencias de uso diferentes.
- **Condiciones operativas**: la disponibilidad de servicios, las características del territorio y las condiciones de prestación pueden influir en la utilización.

Las frecuencias no necesariamente son iguales para toda la población. Cuando un mismo servicio o tecnología presenta comportamientos diferentes entre grupos poblacionales, es necesario analizar nuevamente las características de estos grupos y establecer los ponderadores correspondientes. Por esta razón, en algunos casos resulta necesario dividir la población inicialmente definida en grupos que presenten características o condiciones operativas diferenciadas.

Por ejemplo, un servicio puede presentar una frecuencia de utilización diferente entre grupos de población debido a sus características epidemiológicas, edad, ubicación territorial o condiciones de acceso. En estos casos, aplicar una única frecuencia al total de la población podría generar una estimación que no represente adecuadamente el comportamiento esperado.

La información histórica de utilización constituye, por tanto, un elemento importante para establecer las frecuencias. En este proceso, los datos provenientes de los registros de prestación deben analizarse teniendo en cuenta la población objeto y las condiciones bajo las cuales se produjeron las atenciones. La información debe ser consistente y encontrarse depurada para evitar que registros que no correspondan a la población o al servicio analizado afecten las estimaciones.

En la construcción de la nota técnica, las frecuencias de uso permiten relacionar la población susceptible, los servicios y tecnologías en salud y la utilización esperada durante el periodo del acuerdo de voluntades. De esta manera, se generan insumos para las proyecciones que posteriormente se relacionarán con los costos y demás elementos de la nota técnica.

2.3. Análisis de la oferta y la demanda de servicios

El análisis de la oferta y la demanda permite relacionar las necesidades de la población con la capacidad disponible para atenderlas y con el comportamiento observado en la utilización de los servicios de salud. Esta información contribuye a interpretar los datos históricos y a establecer proyecciones coherentes con las condiciones de la población objeto y del territorio.

- **La oferta de servicios de salud**: se relaciona con la capacidad disponible para prestar los servicios y tecnologías requeridos por una población. Para su análisis pueden considerarse aspectos como la disponibilidad de talento humano, los servicios habilitados, la infraestructura, los equipos, los

horarios de atención y las condiciones territoriales que pueden influir en la prestación.

- **La demanda de servicios de salud**: corresponde a los servicios que la población solicita o utiliza efectivamente. Como se explicó anteriormente, la demanda observada no necesariamente representa la totalidad de las necesidades de una población, debido a que pueden existir condiciones que faciliten o limiten el acceso a los servicios.

Por esta razón, el análisis debe considerar tanto la oferta disponible como el comportamiento de la demanda. La relación entre ambas puede variar según las características de la población, el territorio, las condiciones epidemiológicas y las posibilidades de acceso a los servicios.

El análisis de la oferta y la demanda no debe limitarse a una observación puntual. El comportamiento registrado durante diferentes periodos permite identificar tendencias y variaciones relevantes para las proyecciones de la nota técnica. Para este análisis pueden considerarse los siguientes aspectos:

- **Comportamiento de la utilización**: analizar los servicios y tecnologías utilizados durante diferentes periodos, teniendo en cuenta las condiciones en las que se produjeron las atenciones.
- **Frecuencia esperada**: cuando existen guías de práctica clínica o Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) que permiten establecer una frecuencia esperada, estas pueden utilizarse como referentes para analizar la utilización de determinados servicios.
- **Información histórica**: cuando la demanda presenta mayor variabilidad, la información histórica de la misma población o de poblaciones comparables

puede aportar elementos para establecer las estimaciones correspondientes.

- **Cambios en la población**: considerar las variaciones en el tamaño y las características demográficas o epidemiológicas de la población durante el periodo analizado.
- **Cambios en la oferta**: identificar modificaciones en la disponibilidad de servicios, talento humano, infraestructura u otras condiciones que puedan influir en el comportamiento observado.
- **Condiciones de acceso y prestación**: considerar factores que puedan facilitar o limitar la utilización de los servicios, como las condiciones territoriales y operativas.

Una variación en el número de atenciones no necesariamente significa que hayan cambiado las necesidades de salud de la población; también puede estar relacionada con modificaciones en la población, la oferta disponible, el acceso o las condiciones de prestación.

En la construcción de la nota técnica, el análisis conjunto de la oferta y la demanda permite relacionar la capacidad disponible, la utilización observada y las necesidades de la población objeto. Esta información complementa el análisis de las frecuencias de uso y proporciona elementos para sustentar las proyecciones de servicios y tecnologías durante el periodo del acuerdo de voluntades.

Por ejemplo, una población puede presentar una necesidad determinada de atención, pero la utilización registrada puede ser inferior debido a dificultades de acceso, disponibilidad limitada de servicios o condiciones territoriales. En este caso, analizar únicamente el número histórico de atenciones podría no representar

adecuadamente las necesidades de la población. Por ello, la interpretación de los datos debe considerar conjuntamente las características de la población, la demanda observada y la capacidad de oferta disponible.

2.4. Validación de los soportes de atención

La información utilizada para establecer las frecuencias de uso debe corresponder a atenciones efectivamente realizadas. Por esta razón, antes de utilizar los datos históricos como insumo para la construcción de la nota técnica, es necesario validar los soportes que respaldan la prestación de los servicios y tecnologías en salud.

Los soportes de atención corresponden a la documentación clínica y administrativa que permite acreditar la prestación de un servicio o tecnología en salud. Entre estos pueden encontrarse la historia clínica, la orden médica, el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) asociado y los documentos relacionados con la facturación electrónica en salud.

La validación de estos soportes permite comprobar que la información utilizada para analizar las frecuencias de uso corresponde a servicios efectivamente prestados y que los registros guardan relación con la población objeto y con los servicios analizados. Para este proceso pueden considerarse los siguientes aspectos:

- **Correspondencia de la atención**: verificar que el soporte permita establecer que el servicio o tecnología fue efectivamente prestado.
- **Identificación del servicio**: comprobar que el servicio o tecnología registrado corresponda al código y denominación utilizados en el análisis.

- **Correspondencia con la población**: verificar que la atención corresponda a personas que hacen parte de la población objeto o susceptible definida para el análisis.
- **Consistencia de los registros**: identificar posibles duplicidades, inconsistencias o errores de codificación que puedan alterar las frecuencias de uso.
- **Relación entre los soportes**: comprobar la correspondencia entre los documentos clínicos, los registros de prestación y la información utilizada para el análisis histórico.
- **Soportes de facturación**: considerar la documentación asociada a la factura electrónica en salud y los requisitos establecidos para respaldar la prestación de los servicios.

La validación también debe considerar el marco normativo relacionado con la auditoría, las devoluciones, las glosas y las respuestas. La Resolución 2284 de 2023, modificada por la Resolución 1885 de 2024, establece disposiciones relacionadas con estos procesos, mientras que la Circular Conjunta 007 de 2025 del Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud aborda aspectos relacionados con la justificación de las glosas y su utilización dentro de los procesos de facturación.

Es importante diferenciar la validación de los soportes de la función de la nota técnica. La nota técnica utiliza información histórica para analizar el comportamiento de las frecuencias de uso y sustentar proyecciones; por tanto, la validación busca garantizar la calidad y correspondencia de los datos utilizados como insumo, pero no convierte la nota técnica en un mecanismo de auditoría de cada servicio prestado.

Por ejemplo, para proyectar la frecuencia de un determinado servicio, se dispone de registros históricos de atención. Antes de utilizar estos datos, se identifican registros duplicados, atenciones correspondientes a personas que no pertenecen a la población objeto y registros cuyo código no corresponde al servicio analizado. Después de realizar la validación y depuración, los datos que cumplen las condiciones establecidas pueden utilizarse como insumo para analizar el comportamiento histórico y establecer las frecuencias correspondientes.

3. Fundamentos de la contratación en salud

La construcción de una nota técnica requiere comprender el contexto en el que se establecen los acuerdos de voluntades entre las entidades responsables del pago, los prestadores de servicios de salud y los proveedores de tecnologías en salud. Estos acuerdos definen las condiciones bajo las cuales se organiza y desarrolla la prestación de los servicios y tecnologías requeridos por una población determinada.

En este contexto, la contratación en salud se relaciona con aspectos normativos, administrativos, técnicos y financieros que deben considerarse al establecer las condiciones del acuerdo. Entre ellos se encuentran las modalidades de pago, la identificación de los servicios y tecnologías, las condiciones de prestación, los mecanismos de seguimiento y la información que sustenta las estimaciones realizadas.

El Decreto 441 de 2022, que modificó y adicionó disposiciones del Decreto 780 de 2016 en materia de acuerdos de voluntades, establece elementos relacionados con la contratación entre las entidades responsables de pago, los prestadores de servicios de salud y los proveedores de tecnologías en salud. Dentro de este marco, la nota técnica constituye un elemento asociado a los acuerdos de voluntades y proporciona información para sustentar aspectos relacionados con la población, los servicios y tecnologías, las frecuencias de uso y los riesgos considerados.

El análisis de estos fundamentos permite comprender cómo se relacionan las condiciones de contratación con la información utilizada para construir y hacer seguimiento a la nota técnica. Para ello, este apartado aborda:

- **Marco normativo aplicable a los acuerdos de voluntades**: principales disposiciones que regulan las relaciones entre los actores que participan en la contratación de servicios y tecnologías en salud.
- **Modalidades de pago**: mecanismos mediante los cuales se establece la forma de reconocimiento y pago de los servicios y tecnologías contratados.
- **Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS)**: información relacionada con las atenciones realizadas, utilizada como fuente para analizar la utilización de servicios y tecnologías y sustentar las frecuencias de uso.

El conocimiento de estos elementos permite relacionar la información poblacional y de utilización analizada en los apartados anteriores con las condiciones bajo las cuales se estructuran los acuerdos de voluntades y se desarrolla la contratación en salud.

3.1. Marco normativo aplicable a los acuerdos de voluntades

Los acuerdos de voluntades en el sector salud establecen las condiciones bajo las cuales se organizan y desarrollan las relaciones entre las Entidades Responsables de Pago (ERP), los Prestadores de Servicios de Salud (PSS) y los Proveedores de Tecnologías en Salud (PTS). Su regulación busca establecer condiciones para la prestación de servicios y tecnologías, así como para el reconocimiento y pago de las atenciones realizadas.

El marco normativo aplicable a estos acuerdos se encuentra principalmente en el Decreto 780 de 2016, Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección

Social, y en las disposiciones que lo han modificado y adicionado. Entre estas se encuentra el Decreto 441 de 2022, que incorporó disposiciones específicas relacionadas con los acuerdos de voluntades y la nota técnica.

Dentro de este marco, los acuerdos de voluntades deben establecer de manera clara las condiciones relacionadas con la prestación de los servicios y tecnologías en salud. Entre los elementos que pueden considerarse se encuentran:

- **Actores que intervienen**: identificación de las entidades responsables de pago, los prestadores de servicios de salud y los proveedores de tecnologías en salud que participan en el acuerdo.
- **Población objeto**: definición de la población a la cual se dirige la prestación de los servicios y tecnologías.
- **Servicios y tecnologías**: identificación de las atenciones que hacen parte del acuerdo, utilizando las codificaciones correspondientes.
- **Frecuencias de uso**: estimación de la utilización esperada de los servicios y tecnologías durante el periodo establecido.
- **Condiciones económicas**: definición de los valores y condiciones de reconocimiento y pago de acuerdo con la modalidad pactada.
- **Nota técnica**: incorporación de la información que sustenta las estimaciones de servicios, tecnologías, frecuencias, costos y demás elementos requeridos según el acuerdo.
- **Seguimiento**: establecimiento de mecanismos que permitan analizar el comportamiento de los servicios, las frecuencias de uso, los costos y los riesgos durante la ejecución del acuerdo.

El Decreto 441 de 2022 establece que la nota técnica hace parte de los elementos asociados a los acuerdos de voluntades y la define como una herramienta de transparencia y eficiencia entre las partes. Esta refleja información detallada sobre los servicios y tecnologías de salud, sus frecuencias de uso estimadas, los costos individuales y el valor total correspondiente a la población o grupo de riesgo, de acuerdo con la duración y la modalidad de pago pactada.

Por otra parte, el marco de los acuerdos de voluntades se relaciona con la gestión del riesgo en salud y con el seguimiento de los resultados de la atención. La nota técnica proporciona información que puede utilizarse para analizar desviaciones en las frecuencias de uso y los costos, así como para identificar situaciones que requieran ajustes durante la ejecución del acuerdo.

En este sentido, el conocimiento del marco normativo permite comprender que la contratación en salud no se limita a establecer un valor económico por los servicios prestados. Los acuerdos de voluntades articulan elementos relacionados con la población, las necesidades de atención, los servicios y tecnologías, las modalidades de pago, la gestión del riesgo y el seguimiento de la prestación. Estos elementos constituyen el contexto normativo y operativo en el que se construye y utiliza la nota técnica.

3.2. Modalidades de pago

Las modalidades de pago establecen la forma en que se reconoce económicamente la prestación de los servicios y tecnologías en salud dentro de un acuerdo de voluntades. Su elección se relaciona con las características de la población,

los servicios contratados, las frecuencias de uso estimadas y la distribución de los riesgos entre las partes.

De acuerdo con el enfoque presentado en el insumo, las modalidades de pago pueden clasificarse en prospectivas y retrospectivas, según el momento en que se establece el reconocimiento económico frente a la prestación de los servicios.

A. **Modalidades de pago prospectivas**: el reconocimiento económico se establece antes de que se produzca la atención, a partir de una proyección de la población, los servicios o tecnologías y las frecuencias de uso esperadas. Entre las modalidades señaladas se encuentran la capitación, el pago global prospectivo (PGP), el pago por paquete o canasta y otras formas de pago previamente acordadas.

Estas modalidades requieren estimaciones que permitan establecer los recursos necesarios para atender a la población durante el periodo definido. Por ello, la nota técnica adquiere especial importancia como instrumento para sustentar las frecuencias de uso, los costos y los valores asociados a los servicios y tecnologías incluidos en el acuerdo.

Entre las modalidades prospectivas pueden considerarse:

- **Pago por capitación**: establece un valor por persona durante un periodo determinado, de acuerdo con las condiciones definidas en el acuerdo de voluntades.
- **Pago global prospectivo (**PGP): establece anticipadamente un valor global para atender un conjunto determinado de servicios, población y condiciones pactadas.

- Pago por paquete o canasta: establece un valor para un conjunto definido de servicios y tecnologías relacionados con una atención o proceso determinado.

En estas modalidades, las estimaciones de población y frecuencia de uso tienen una relación directa con la planeación de los recursos requeridos para la prestación. El comportamiento real de la utilización puede generar diferencias frente a las proyecciones iniciales, por lo que el seguimiento de la ejecución del acuerdo constituye un elemento relevante.

B. **Modalidades de pago retrospectivas**: el reconocimiento económico se determina después de realizada la prestación, de acuerdo con los servicios y tecnologías efectivamente utilizados. El insumo identifica el pago por evento como ejemplo de esta modalidad.

En este caso, el valor reconocido depende de las atenciones efectivamente realizadas y de las condiciones económicas establecidas entre las partes. Por esta razón, la información relacionada con los servicios prestados, los soportes de atención y los registros de utilización adquiere especial importancia para el proceso de reconocimiento y pago.

La modalidad de pago seleccionada debe guardar correspondencia con los elementos definidos en el acuerdo de voluntades y con la información utilizada para construir la nota técnica. Esta última permite relacionar la población objeto, los servicios y tecnologías, las frecuencias de uso, los costos y el periodo de contratación.

De esta manera, las modalidades de pago pueden organizarse así:

Tabla 5. Modalidades de pago en los acuerdos de voluntades

Tipo de modalidad	Momento del reconocimiento económico	Ejemplos señalados en el insumo	Relación con la nota técnica
Prospectiva	Antes de la prestación, con base en proyecciones.	Capitación, PGP, paquete o canasta.	Sustenta las estimaciones de población, frecuencias, costos y recursos requeridos.
Retrospectiva	Después de la prestación, según la utilización efectiva.	Pago por evento.	Utiliza información de los servicios efectivamente prestados para determinar el reconocimiento.

En consecuencia, comprender las modalidades de pago permite interpretar cómo las estimaciones realizadas en la nota técnica se relacionan con las condiciones económicas y operativas del acuerdo de voluntades. La modalidad seleccionada también determina qué información debe analizarse para realizar el seguimiento del

comportamiento de los servicios, las frecuencias de uso y los costos durante la ejecución del acuerdo.

3.3. Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS)

El Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) es el conjunto de datos que contiene información relacionada con la prestación o provisión de servicios y tecnologías de salud a los usuarios. Esta información se utiliza en los procesos de prestación y facturación, así como en actividades de dirección, regulación y control del sector salud.

De acuerdo con la Resolución 2275 de 2023, el RIPS es generado, validado y enviado como soporte de la factura de venta por los facturadores electrónicos del sector salud, entre ellos los prestadores de servicios de salud y los proveedores de tecnologías en salud.

La información registrada se organiza en diferentes grupos de datos, entre los que se encuentran:

- **Datos de la transacción**: información relacionada con la operación registrada.
- **Datos de los usuarios**: información necesaria para identificar y caracterizar al usuario de los servicios.
- **Datos de los servicios y tecnologías de salud y valores facturados**: información relacionada con las atenciones realizadas y los valores correspondientes.

Dentro de los servicios y tecnologías registrados se incluyen datos de consultas, procedimientos, urgencias con observación, hospitalización, recién nacidos, medicamentos y otros servicios.

En la construcción de la nota técnica, el RIPS constituye una fuente de información para analizar el comportamiento histórico de los servicios y tecnologías efectivamente utilizados. Su análisis permite establecer frecuencias de uso y relacionarlas con la población objeto y susceptible previamente identificada.

La información histórica debe ser analizada teniendo en cuenta el periodo de referencia, la población objeto, los servicios o tecnologías considerados y las condiciones en las que se produjeron las atenciones. Además, es necesario realizar procesos de validación y depuración para identificar posibles duplicidades, inconsistencias o registros que no correspondan con el análisis que se pretende realizar.

Por ejemplo, si se requiere establecer la frecuencia histórica de un procedimiento, los registros del RIPS pueden utilizarse para determinar cuántas veces fue realizado durante un periodo y relacionar este resultado con la población correspondiente. De esta manera, el RIPS aporta información para estimar el comportamiento de utilización que posteriormente puede considerarse en las proyecciones de la nota técnica.

En este sentido, el RIPS no debe analizarse de manera aislada. Su información puede complementarse con otras fuentes, como la BDUA, para delimitar la población; el SIVIGILA, para analizar determinados eventos de interés en salud pública; y la caracterización poblacional y el ASIS, para contextualizar las condiciones de salud y del territorio.

En síntesis, el RIPS aporta información sobre las atenciones efectivamente realizadas y constituye un insumo para analizar la utilización histórica de los servicios y tecnologías. Su adecuada validación y análisis contribuyen a sustentar las frecuencias de uso empleadas en la construcción de la nota técnica.

4. Calidad y atención en el contexto de la contratación en salud

La calidad de la atención en salud constituye un elemento fundamental en la prestación de servicios y tecnologías y se relaciona con las condiciones bajo las cuales se desarrollan los acuerdos de voluntades entre las entidades responsables de pago, los prestadores de servicios de salud y los proveedores de tecnologías en salud. Por esta razón, la contratación en salud no se limita a establecer condiciones económicas, sino que también debe considerar aspectos relacionados con la capacidad de prestación, la calidad de la atención, la gestión del riesgo y la seguridad del paciente.

En Colombia, estos aspectos se articulan con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud (SOGCS), que establece mecanismos orientados a promover y mantener las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de salud. Dentro de este sistema se encuentran componentes como la habilitación de servicios, la auditoría para el mejoramiento de la calidad, el Sistema Único de Acreditación y el Sistema de Información para la Calidad.

En el contexto de la nota técnica, el análisis de la calidad adquiere importancia porque las características de los servicios contratados, las condiciones de prestación y los resultados de la atención pueden relacionarse con el comportamiento de las frecuencias de uso, los costos y los riesgos asociados al acuerdo de voluntades. De igual manera, la disponibilidad de servicios habilitados y las condiciones de atención constituyen elementos que deben considerarse al analizar la oferta y las necesidades de la población objeto.

La seguridad del paciente también se relaciona con este contexto. La aplicación de guías de práctica clínica, protocolos de atención, barreras de seguridad y mecanismos para identificar y gestionar eventos adversos contribuye a reducir riesgos asociados a la prestación. Estas condiciones se relacionan, a su vez, con el riesgo técnico que puede presentarse cuando existen variaciones en la utilización de recursos, complicaciones o resultados de la atención que podrían estar asociados con factores relacionados con la prestación.

Asimismo, las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) proporcionan referentes para organizar las intervenciones requeridas de acuerdo con las características de la población, las condiciones de salud y los grupos de riesgo. Su consideración en la construcción de la nota técnica permite relacionar las intervenciones y frecuencias de atención con las necesidades identificadas en la población objeto.

En este contexto, el apartado aborda los siguientes elementos:

- **Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud**: estructura y componentes relacionados con la calidad de la atención.
- **Habilitación de servicios de salud**: condiciones que deben cumplir los prestadores para ofertar y prestar los servicios habilitados.
- **Gestión del riesgo y seguridad del paciente**: elementos relacionados con la identificación, prevención y seguimiento de riesgos asociados a la atención.
- **Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS)**: organización de las intervenciones de atención de acuerdo con las condiciones y necesidades de la población.

El análisis conjunto de estos elementos permite comprender cómo las condiciones de calidad y atención se relacionan con la prestación de los servicios y tecnologías, la gestión de los riesgos y la información que sustenta la construcción y seguimiento de la nota técnica.

4.1. Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud

El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud (SOGCS) establece el conjunto de condiciones, mecanismos y procesos orientados a promover y mantener la calidad de la atención en salud. Su funcionamiento se relaciona con las condiciones en las que los servicios son prestados y con los procesos de seguimiento y mejoramiento de la atención.

El SOGCS se encuentra reglamentado en el Decreto 780 de 2016 y comprende cuatro componentes: el Sistema Único de Habilitación, la Auditoría para el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud (PAMEC), el Sistema Único de Acreditación y el Sistema de Información para la Calidad.

Estos componentes cumplen funciones diferentes y se relacionan entre sí:

- **Sistema Único de Habilitación**: establece las condiciones que deben cumplir los prestadores para su inscripción y para la habilitación de los servicios de salud que ofertan y prestan.
- **Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud (PAMEC)**: comprende procesos de evaluación y seguimiento orientados al mejoramiento de la calidad de la atención y a la identificación de desviaciones que requieren intervención.

- **Sistema Único de Acreditación**: corresponde a un proceso voluntario de evaluación de estándares superiores de calidad por parte de las instituciones que participan en este proceso.
- **Sistema de Información para la Calidad**: proporciona información e indicadores para el monitoreo de la calidad y el seguimiento de su comportamiento. La Resolución 256 de 2016 establece disposiciones relacionadas con este sistema y con los indicadores para el monitoreo de la calidad en salud.

En el contexto de los acuerdos de voluntades, estos componentes permiten relacionar las condiciones de calidad con la prestación de los servicios y tecnologías contratados. Por ejemplo, la habilitación permite verificar que los servicios incluidos en el acuerdo correspondan a servicios que cuentan con las condiciones requeridas para su prestación. A su vez, los procesos de auditoría y los sistemas de información aportan elementos para realizar seguimiento al comportamiento de la atención y a sus resultados.

Esta relación también es importante para la construcción de la nota técnica. La información sobre la población, los servicios y tecnologías, las frecuencias de uso y los costos debe guardar correspondencia con las condiciones reales de prestación. Por ello, la capacidad de los prestadores, los servicios habilitados y los resultados asociados a la atención constituyen elementos que pueden complementar el análisis realizado durante la estructuración y seguimiento del acuerdo de voluntades.

De esta manera, el SOGCS proporciona un marco para comprender que la contratación en salud debe considerar no solamente qué servicios se requieren y con qué frecuencia, sino también bajo qué condiciones pueden ser prestados y cómo se

realiza el seguimiento de su calidad. Estos elementos se relacionan con la gestión del riesgo, la seguridad del paciente y la sostenibilidad de los acuerdos de voluntades.

4.2. Habilitación de servicios de salud

La habilitación tiene una relación directa con la contratación de servicios de salud, debido a que permite establecer si un prestador cuenta con los servicios habilitados que corresponden a las atenciones que pretende ofertar o contratar.

En este contexto, el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) constituye una referencia para identificar los servicios habilitados y las condiciones registradas de los prestadores. Esta información también puede relacionarse con la identificación y codificación de servicios desarrollada anteriormente en el componente.

Por esta razón, antes de incluir un servicio en un acuerdo de voluntades, es necesario verificar que corresponda a un servicio habilitado y que exista coherencia entre la oferta disponible, las necesidades de la población y los servicios y tecnologías considerados en la nota técnica. El insumo señala que un servicio no habilitado no debe incorporarse al acuerdo de voluntades, independientemente de que se hayan calculado sus frecuencias de uso o costos.

La relación entre habilitación y nota técnica puede comprenderse a partir de tres elementos:

a) **Población y necesidades**: permiten determinar qué servicios y tecnologías pueden requerirse.
b) **Oferta disponible**: permite establecer si existen prestadores con capacidad para atender las necesidades identificadas.

c) **Servicios habilitados**: permiten verificar que los servicios considerados en el acuerdo correspondan a aquellos que el prestador está habilitado para prestar.

De esta manera, la información sobre habilitación contribuye a que las proyecciones de servicios, frecuencias y costos de la nota técnica correspondan con las condiciones reales de prestación.

Por ejemplo, si el análisis de la población susceptible establece la necesidad de proyectar un determinado servicio especializado, la construcción de la nota técnica debe considerar no solo la frecuencia esperada y el costo asociado. También debe verificarse que el prestador o la red definida para el acuerdo cuente con dicho servicio habilitado y con las condiciones requeridas para su prestación.

En consecuencia, la habilitación constituye un elemento que articula la calidad, la oferta de servicios y la contratación en salud, y aporta información necesaria para establecer la correspondencia entre los servicios proyectados en la nota técnica y la capacidad efectiva de prestación.

4.3. Gestión del riesgo y seguridad del paciente

La gestión del riesgo y la seguridad del paciente son elementos relacionados con la calidad de la atención en salud. En el contexto de los acuerdos de voluntades, permiten identificar situaciones que pueden afectar los resultados de la atención, la utilización de los servicios y tecnologías y los costos asociados a su prestación.

La gestión del riesgo clínico se relaciona con los procesos de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud, mediante los cuales se identifican y corrigen desviaciones en los procesos de atención. Por su parte, la seguridad del paciente se orienta a prevenir y reducir los daños evitables asociados con la atención.

Aunque ambos conceptos están relacionados, es posible diferenciarlos de la siguiente manera:

Tabla 6. Diferencias entre gestión del riesgo y seguridad del paciente

Gestión del riesgo	**Seguridad del paciente**
Identifica y gestiona situaciones que pueden afectar los resultados de la atención.	Busca prevenir y reducir daños evitables asociados a la atención.
Considera los riesgos asociados con los procesos de prestación.	Se concentra en las condiciones de seguridad durante la atención.
Puede apoyarse en auditorías, indicadores y seguimiento de resultados.	Incluye la aplicación de guías y protocolos, el seguimiento de eventos adversos y las barreras de seguridad.
Permite identificar situaciones que pueden generar variaciones en la utilización de servicios y tecnologías.	Contribuye a prevenir complicaciones y eventos adversos durante la atención.

Entre las acciones relacionadas con la seguridad del paciente se encuentran la adherencia a las guías de práctica clínica y protocolos de atención, el seguimiento de los eventos adversos y la implementación de barreras de seguridad en procesos asistenciales que presentan mayores riesgos.

Estos elementos se relacionan con el riesgo técnico, que corresponde a las variaciones en la utilización de recursos, la ocurrencia de complicaciones o la severidad asociadas con factores no previsibles en la atención o que no se encuentran soportados en la evidencia científica. El riesgo técnico comprende dos componentes:

- **Riesgo técnico de morbilidad evitable**: se relaciona con complicaciones clínicas o aumento de la severidad de una condición de salud asociados con fallas en el modelo de prestación, la seguridad del paciente, la coordinación entre prestadores o la aplicación de guías de práctica clínica y protocolos.
- **Riesgo técnico de utilización**: corresponde a la variabilidad en el uso de servicios y tecnologías en salud que no se encuentra soportada en la evidencia científica.

La relación entre estos elementos y la nota técnica puede comprenderse mediante un ejemplo. Una complicación asociada con una falla en la atención puede generar nuevas consultas, procedimientos, medicamentos u hospitalizaciones. Esto puede modificar las frecuencias de uso y los costos inicialmente proyectados. De igual manera, la utilización de servicios o tecnologías que no esté sustentada en la evidencia puede generar diferencias frente a las frecuencias esperadas.

Por esta razón, la gestión del riesgo y la seguridad del paciente deben considerarse junto con la información sobre la población, los servicios y tecnologías, las frecuencias de uso y las condiciones de prestación. Su análisis permite relacionar la calidad de la atención con los riesgos y las variaciones que pueden presentarse durante la ejecución del acuerdo de voluntades y que deben ser consideradas en el seguimiento de la nota técnica.

4.4. Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS)

Las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) constituyen una herramienta para organizar las intervenciones en salud de acuerdo con las necesidades de las personas, las familias y las comunidades. Su implementación permite articular las acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, según las condiciones y riesgos identificados en la población.

Las RIAS se desarrollan en el marco del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) y se encuentran reglamentadas principalmente por la Resolución 3280 de 2018, mediante la cual se adoptaron los lineamientos técnicos y operativos de las rutas para la promoción y mantenimiento de la salud y para la atención de grupos de riesgo.

En este contexto, las RIAS permiten organizar la atención de acuerdo con las características y necesidades de diferentes grupos de población. Su aplicación contempla intervenciones individuales, colectivas y poblacionales, así como la participación de los diferentes actores responsables de la atención.

Para la construcción de la nota técnica, las RIAS pueden aportar elementos para identificar los servicios y tecnologías que pueden requerirse de acuerdo con las características de la población objeto y sus condiciones de salud. También pueden constituir un referente para analizar las frecuencias esperadas de determinadas intervenciones, cuando estas se encuentran definidas dentro de las rutas correspondientes.

Por ejemplo, si la población objeto incluye personas con condiciones de salud que hacen parte de un grupo de riesgo contemplado en una RIAS, las intervenciones establecidas en la ruta pueden considerarse como referente para identificar los servicios requeridos y analizar su frecuencia de utilización.

De esta manera, la relación entre las RIAS y la nota técnica puede establecerse a partir de:

- **Características de la población**: permiten identificar los grupos de población y de riesgo a los que pueden dirigirse las intervenciones.
- **Servicios y tecnologías**: orientan la identificación de las intervenciones requeridas según las condiciones de salud y los grupos de riesgo.
- **Frecuencias de uso**: proporcionan referentes para analizar la utilización esperada de determinadas intervenciones.
- **Gestión del riesgo**: contribuyen a orientar intervenciones relacionadas con la prevención y el manejo de condiciones de salud.
- **Planeación de la atención**: permiten relacionar las necesidades identificadas con la organización de los servicios requeridos.

En consecuencia, las RIAS constituyen un referente para relacionar las necesidades de la población con las intervenciones y servicios de salud requeridos. En la nota técnica, esta información puede complementar el análisis de la población susceptible, los servicios y tecnologías y las frecuencias de uso que sustentan las proyecciones del acuerdo de voluntades.

5. Manuales tarifarios y glosas

Los manuales tarifarios y las glosas se relacionan con los procesos económicos y administrativos asociados a la prestación y al reconocimiento de los servicios y tecnologías en salud. Su análisis permite comprender cómo se establecen los valores de referencia para los servicios contratados y cómo se gestionan las diferencias o inconsistencias identificadas durante los procesos de facturación y auditoría.

En el contexto de los acuerdos de voluntades, las partes deben establecer las condiciones económicas bajo las cuales se reconocerán y pagarán los servicios y tecnologías contratados. Para ello, pueden utilizar diferentes referentes tarifarios, de acuerdo con la modalidad de contratación y las condiciones pactadas.

Los manuales tarifarios contienen referencias para la identificación y valoración económica de determinados servicios y procedimientos. Su utilización debe relacionarse con las condiciones establecidas en el acuerdo de voluntades y con los servicios y tecnologías que hacen parte de este.

Por otra parte, las glosas corresponden a objeciones o diferencias identificadas frente a las facturas presentadas por los servicios y tecnologías en salud. Estas pueden estar relacionadas con aspectos administrativos, de prestación, facturación o soportes, y requieren procesos de revisión, respuesta y gestión entre las partes.

En este contexto, ambos elementos guardan relación con la información utilizada en la construcción y seguimiento de la nota técnica. Las tarifas permiten establecer los valores asociados a los servicios y tecnologías considerados, mientras que el análisis de las glosas puede aportar información sobre inconsistencias o situaciones que afectan el reconocimiento y pago de los servicios.

Este apartado aborda los siguientes temas:

- Tipos de tarifas, de acuerdo con los referentes utilizados para establecer los valores de los servicios y tecnologías.
- Lineamientos normativos de los manuales tarifarios, que permiten comprender el marco aplicable a su utilización en los procesos de contratación.
- Glosas en la contratación de servicios de salud, sus características y su relación con los procesos de facturación, auditoría y reconocimiento de los servicios prestados.

El análisis conjunto de estos elementos permite relacionar las condiciones económicas de la contratación con la prestación efectiva de los servicios y tecnologías y con los procesos de reconocimiento y pago derivados de los acuerdos de voluntades.

5.1. Tipos de tarifas

Los manuales tarifarios son referentes utilizados para establecer o acordar el valor económico de los servicios y tecnologías en salud. En los acuerdos de voluntades, las partes pueden definir las condiciones económicas de la contratación y establecer los referentes tarifarios que utilizarán para reconocer los servicios contratados.

En Colombia existen diferentes referentes tarifarios que pueden utilizarse en los procesos de contratación en salud. Entre los más conocidos se encuentran el Manual Tarifario SOAT y el Manual Tarifario ISS 2001. También pueden establecerse tarifas propias mediante acuerdos entre las partes, de acuerdo con las condiciones definidas en el acuerdo de voluntades.

Entre los principales referentes tarifarios utilizados en los procesos de contratación en salud se encuentran los siguientes:

- **Manual Tarifario SOAT**

El Manual Tarifario SOAT tiene como antecedente el régimen tarifario establecido mediante el Decreto 2423 de 1996, posteriormente compilado en el Decreto 780 de 2016. Este referente establece la nomenclatura, clasificación y tarifas para determinados procedimientos médico-quirúrgicos y hospitalarios.

Su aplicación obligatoria está asociada a situaciones específicas establecidas en la normativa, entre ellas la atención de víctimas de accidentes de tránsito y determinados eventos catastróficos, así como la atención inicial de urgencias cuando no existe un acuerdo previo entre las partes. Para otros procesos de contratación, puede utilizarse como referente cuando así se establezca en el acuerdo de voluntades.

- **Manual Tarifario ISS 2001**

El denominado Manual Tarifario ISS 2001 corresponde a un referente histórico utilizado en procesos de negociación de servicios de salud. Aunque no ha tenido una actualización oficial posterior a su expedición, puede encontrarse como referencia en algunos procesos de contratación cuando las partes acuerdan utilizarlo.

Es importante diferenciar entre un manual utilizado como referente de negociación y una tarifa de aplicación obligatoria. La utilización de un manual como referente depende de las condiciones pactadas por las partes y del marco normativo aplicable al acuerdo.

En aquellos acuerdos de voluntades en los que no exista una tarifa de aplicación obligatoria para el servicio o tecnología correspondiente, las partes pueden establecer los valores que reconocerán, de acuerdo con las condiciones de contratación y el referente tarifario que hayan definido.

Por esta razón, antes de utilizar una tarifa para construir la nota técnica es necesario identificar qué referente tarifario se utilizará, cuáles son las condiciones pactadas y qué servicios y tecnologías están incluidos en el acuerdo de voluntades.

En la construcción de la nota técnica, esta definición es importante porque los valores tarifarios se relacionan con las frecuencias de uso y con la población objeto. La combinación de estos elementos permite estimar los costos asociados a los servicios y tecnologías que serán considerados en el acuerdo.

Por ejemplo, si un acuerdo de voluntades establece como referente una tarifa determinada para un procedimiento y la nota técnica proyecta una frecuencia de utilización para la población objeto, el valor tarifario y la frecuencia estimada constituyen elementos para calcular el costo esperado de ese procedimiento durante el periodo de contratación.

5.2. Lineamientos normativos de los manuales tarifarios

Los manuales tarifarios hacen parte de los referentes utilizados para establecer los valores de los servicios y tecnologías en salud. Su aplicación debe analizarse de acuerdo con el marco normativo vigente y con las condiciones establecidas en el acuerdo de voluntades entre las partes.

Entre las principales normas relacionadas con estos referentes tarifarios se encuentran las siguientes:

Tabla 7. Principales referentes normativos relacionados con las tarifas en salud

Norma	Aspecto relacionado con las tarifas	Aplicación en la contratación
Decreto 2423 de 1996	Establece la nomenclatura, clasificación y régimen tarifario de determinados procedimientos médico-quirúrgicos y hospitalarios.	Su aplicación obligatoria corresponde a los casos establecidos en la normativa.
Decreto 780 de 2016	Compila las disposiciones reglamentarias del sector salud, incluidas las relacionadas con el régimen tarifario.	Constituye un referente normativo para la aplicación de las disposiciones tarifarias.
Decreto 441 de 2022	Regula aspectos de los acuerdos de voluntades y establece disposiciones relacionadas con las tarifas y las modalidades de pago.	Orienta la definición de las condiciones económicas entre las partes.

El Decreto 2423 de 1996 estableció la nomenclatura y clasificación de los procedimientos médico-quirúrgicos y hospitalarios y determinó un régimen tarifario para estos servicios. Posteriormente, sus disposiciones fueron incorporadas al Decreto 780 de 2016, como parte del régimen reglamentario del sector salud.

Es importante precisar que las tarifas establecidas en este régimen no constituyen una tarifa de aplicación general para todos los contratos de servicios de salud. Su aplicación obligatoria corresponde a los casos establecidos por la normativa, entre ellos determinados eventos como accidentes de tránsito, desastres naturales, atentados terroristas y otros eventos catastróficos, así como la atención inicial de urgencias cuando no existe un acuerdo previo entre las partes.

Para los demás procesos de contratación, las partes pueden establecer las condiciones económicas del acuerdo de voluntades, de acuerdo con el marco normativo y con el referente tarifario que hayan definido.

En este sentido, el Decreto 441 de 2022 establece disposiciones relacionadas con los acuerdos de voluntades y señala que las tarifas deben guardar correspondencia con la modalidad de pago pactada.

En la construcción de la nota técnica, estos lineamientos deben relacionarse con:

- **Servicios y tecnologías contratados**: identificar los servicios y tecnologías a los cuales corresponde cada valor tarifario.
- **Referente tarifario**: establecer el manual o referente utilizado para determinar los valores.
- **Modalidad de pago**: verificar que las tarifas sean coherentes con la modalidad de pago pactada en el acuerdo.
- **Condiciones económicas**: considerar los valores acordados entre las partes para los servicios y tecnologías incluidos.

- **Vigencia**: utilizar valores que correspondan al periodo objeto del acuerdo y a las disposiciones aplicables.
- **Nota técnica**: relacionar los valores tarifarios con la población objeto, las frecuencias de uso y los servicios y tecnologías proyectados.

Por ejemplo, si la nota técnica proyecta una determinada frecuencia de utilización para un procedimiento, el valor tarifario acordado permite establecer el costo esperado asociado a dicho servicio. De esta manera, las tarifas constituyen uno de los elementos económicos que se relacionan con las proyecciones realizadas en la nota técnica.

5.3. Glosas en la contratación de servicios de salud

Las glosas son objeciones formuladas durante el proceso de auditoría de las cuentas presentadas por los prestadores de servicios de salud o proveedores de tecnologías en salud. Estas pueden generar el no reconocimiento total o parcial de los valores facturados cuando se identifica alguna inconsistencia relacionada con la prestación, facturación, soportes o condiciones establecidas para el reconocimiento de los servicios.

El proceso de glosas hace parte de la revisión de las cuentas en salud y se encuentra relacionado con los procesos de facturación, auditoría y reconocimiento de los servicios y tecnologías prestados. Actualmente, la Resolución 2284 de 2023 establece los soportes de cobro y adopta el Manual Único de Devoluciones, Glosas y Respuestas. Esta resolución fue modificada, entre otras disposiciones, por la Resolución 1885 de 2024.

Para comprender el proceso, es importante diferenciar las devoluciones de las glosas. Las devoluciones corresponden a situaciones que impiden continuar con el trámite de la factura y tienen un procedimiento específico, mientras que las glosas corresponden a objeciones formuladas durante la auditoría de las cuentas. La Resolución 2284 de 2023 establece los procedimientos y soportes aplicables a estos procesos.

En la gestión de las glosas deben considerarse, entre otros, los siguientes aspectos:

- **Causal de la glosa**: la objeción debe corresponder a una causal establecida en el Manual Único de Devoluciones, Glosas y Respuestas. No pueden aplicarse causales diferentes a las allí establecidas.
- **Soportes**: la objeción debe relacionarse con la información y los soportes que respaldan la prestación y facturación de los servicios o tecnologías.
- **Respuesta**: el prestador o proveedor debe analizar la objeción y presentar la respuesta correspondiente dentro de los términos establecidos.
- **Trazabilidad**: las actuaciones relacionadas con la glosa deben permitir identificar la factura, la causal, los valores involucrados y la respuesta presentada.
- **Términos**: las glosas y sus respuestas deben tramitarse dentro de los plazos establecidos en la normativa aplicable.
- **Nuevas glosas**: una vez formuladas las glosas a una factura, no pueden formularse nuevas glosas sobre la misma, salvo aquellas que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta a la glosa inicial.

La Circular Conjunta 007 de 2025, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud, reiteró que las entidades responsables de pago no pueden aplicar glosas o devoluciones injustificadas o por fuera de los plazos establecidos. También señaló que deben utilizarse las causales definidas en el Manual Único de Devoluciones, Glosas y Respuestas y que no pueden exigirse soportes adicionales a los establecidos para el trámite de las facturas.

Las glosas también guardan relación con los manuales tarifarios. Por ejemplo, cuando una factura presenta un valor diferente al que corresponde a la tarifa establecida en el acuerdo de voluntades, puede generarse una objeción relacionada con el valor facturado. Por esta razón, la definición clara de las tarifas y condiciones económicas desde la estructuración del acuerdo contribuye a reducir inconsistencias durante la facturación y auditoría.

En la construcción y seguimiento de la nota técnica, las glosas pueden proporcionar información sobre diferencias entre los servicios y tecnologías proyectados, las condiciones pactadas y los valores efectivamente facturados. Sin embargo, la nota técnica no sustituye el proceso de auditoría de cuentas; su función es proporcionar información para la planeación, estimación y seguimiento de los servicios, tecnologías, frecuencias y costos asociados al acuerdo de voluntades.

6. Elementos generales de la nota técnica

La nota técnica integra información relacionada con la población objeto, los servicios y tecnologías en salud, las frecuencias de uso, los costos y los riesgos asociados a la atención. Su construcción requiere analizar las características y necesidades de la población, la información histórica de utilización y las condiciones establecidas en el acuerdo de voluntades.

De acuerdo con el Decreto 441 de 2022, la nota técnica constituye una herramienta de transparencia y eficiencia entre las partes que suscriben un acuerdo de voluntades. En ella se detallan los servicios y tecnologías de salud, las frecuencias de uso estimadas, los costos individuales y el valor total correspondiente a la población o grupo de riesgo, considerando el periodo de duración del acuerdo y la modalidad de pago pactada.

La información que hace parte de la nota técnica se construye a partir de los análisis desarrollados previamente. La caracterización de la población permite establecer quiénes hacen parte de la población objeto y cuáles son sus necesidades; las fuentes de información y los registros de atención permiten analizar cómo se utilizan los servicios y tecnologías; y las condiciones de contratación, las tarifas y los riesgos permiten establecer los valores y condiciones que deben considerarse en las proyecciones.

Por esta razón, la nota técnica no corresponde únicamente a un cálculo económico. Su construcción articula información poblacional, epidemiológica, asistencial y financiera para sustentar las estimaciones que hacen parte del acuerdo de voluntades.

En este apartado se abordarán tres elementos fundamentales:

- **Características y elementos**: permiten comprender la finalidad de la nota técnica y la información que debe integrar.
- **Servicios, tecnologías y frecuencias de uso**: relacionan la población susceptible con las atenciones que pueden requerirse y la frecuencia esperada de utilización.
- **Riesgo primario y riesgo técnico**: permiten reconocer los riesgos asociados a las condiciones de salud de la población y a la utilización y prestación de los servicios y tecnologías.

De esta manera, los elementos generales de la nota técnica permiten integrar los contenidos desarrollados durante el componente y comprender cómo la información de la población, los servicios, las frecuencias, los costos y los riesgos se relaciona con la planeación y el seguimiento de los acuerdos de voluntades.

6.1. Características y elementos

La nota técnica es una herramienta que permite a las partes de un acuerdo de voluntades planear los procesos de atención, estimar los recursos necesarios para garantizar la prestación de los servicios y tecnologías en salud y realizar el seguimiento de la ejecución del acuerdo.

De acuerdo con el Decreto 441 de 2022, la nota técnica constituye una herramienta de transparencia y eficiencia entre las partes que suscriben el acuerdo de voluntades. En ella se detallan los servicios y tecnologías de salud, las frecuencias de uso estimadas, los costos individuales y el valor total correspondiente a la población o

grupo de riesgo, considerando el periodo de duración pactado y las situaciones que puedan presentarse durante la ejecución del acuerdo.

Por sus características, la nota técnica debe permitir relacionar la información de la población con los servicios y tecnologías requeridos y con los valores económicos asociados. Para ello, debe considerar, entre otros, los siguientes elementos:

- **Población a cargo**: corresponde a la población objeto del acuerdo y constituye la base para realizar las estimaciones.
- **Servicios y tecnologías en salud**: identifica las atenciones que hacen parte del acuerdo de voluntades.
- **Frecuencia de uso estimada**: establece la cantidad esperada de utilización de cada servicio o tecnología durante el periodo definido.
- **Costos individuales**: relaciona cada servicio o tecnología con el valor económico correspondiente.
- **Valor total**: integra los valores estimados para el conjunto de servicios y tecnologías incluidos.
- **Periodo de contratación**: delimita el tiempo durante el cual se realizan las proyecciones y se ejecuta el acuerdo.
- **Población o grupo de riesgo**: permite realizar estimaciones diferenciadas cuando las características de la población o sus condiciones de salud así lo requieren.

Estos elementos no deben analizarse de manera independiente. La nota técnica relaciona la población, los servicios y tecnologías, las frecuencias de uso y los valores económicos para sustentar las condiciones del acuerdo de voluntades. Por ejemplo, la

estimación de una frecuencia de uso para un procedimiento debe relacionarse con la población susceptible de recibirlo y con el valor establecido para dicho procedimiento.

Asimismo, las frecuencias de uso pueden expresarse mediante estimaciones que consideren intervalos de frecuencias esperados, de acuerdo con la metodología utilizada para la construcción de la nota técnica. El insumo señala como referencia intervalos de confianza entre el 90 % y el 99 %.

En este sentido, una nota técnica se caracteriza por ser:

- **Técnica**: se fundamenta en información poblacional, epidemiológica, asistencial y económica.
- **Estimativa**: utiliza información disponible para proyectar frecuencias, costos y valores esperados.
- **Detallada**: relaciona los servicios y tecnologías con sus frecuencias y valores.
- **Relacionada con la población**: las estimaciones corresponden a una población o grupo de riesgo determinado.
- **Vinculada al acuerdo de voluntades**: sus elementos deben guardar correspondencia con las condiciones y modalidad de pago pactadas.
- **Útil para el seguimiento**: permite comparar el comportamiento observado durante la ejecución con las estimaciones realizadas.

Así, la nota técnica puede entenderse como un instrumento que integra información para sustentar la planeación económica y asistencial del acuerdo de voluntades. Su construcción parte de la caracterización de la población y de sus

necesidades y relaciona esta información con los servicios y tecnologías, las frecuencias de uso, los costos y los riesgos que pueden presentarse durante la ejecución.

6.2. Servicios, tecnologías y frecuencias de uso

La nota técnica relaciona los servicios y tecnologías en salud que hacen parte del acuerdo de voluntades con la frecuencia esperada de utilización por parte de la población objeto. Esta relación permite estimar la cantidad de atenciones o tecnologías que podrían requerirse durante el periodo establecido en el acuerdo.

Los servicios y tecnologías deben identificarse de manera precisa y corresponder a las necesidades de la población analizada. Para cada uno se establece una frecuencia de uso de acuerdo con las características de la población, la información histórica disponible y las condiciones en las que se desarrolla la atención.

La frecuencia de uso corresponde a la cantidad estimada de veces que un servicio o tecnología será utilizado por una población durante un periodo determinado. Esta frecuencia no necesariamente es igual para toda la población, debido a que pueden existir diferencias relacionadas con las condiciones de salud, las características demográficas, el territorio o las condiciones operativas de la prestación.

Por esta razón, las frecuencias se establecen teniendo en cuenta:

- **Servicio o tecnología**: cada servicio o tecnología requiere una estimación de frecuencia de uso.
- **Población**: la frecuencia debe relacionarse con la población que puede requerir el servicio o tecnología.

- **Características de la población**: las condiciones demográficas, epidemiológicas o de riesgo pueden generar diferencias en la utilización.
- **Información histórica**: los registros de utilización permiten identificar comportamientos que pueden servir como referencia para las estimaciones.
- **Condiciones operativas**: aspectos como la disponibilidad de servicios, el talento humano y las características del territorio pueden modificar la forma en que se utilizan los servicios.
- **Periodo de contratación**: la frecuencia debe corresponder al tiempo durante el cual se realizará la proyección.

Cuando un mismo servicio o tecnología presenta frecuencias diferentes entre grupos de población, puede ser necesario dividir la población inicialmente definida y establecer los ponderadores correspondientes. Esto permite que la estimación represente las particularidades de cada grupo y evita aplicar una única frecuencia a poblaciones que presentan comportamientos diferentes.

Por ejemplo, si un servicio presenta una frecuencia de uso diferente entre población adulta y población mayor debido a sus características epidemiológicas, la estimación puede realizarse de manera diferenciada para cada grupo. Posteriormente, las frecuencias obtenidas pueden integrarse para establecer la estimación correspondiente al conjunto de la población objeto.

La información histórica constituye un insumo importante para este proceso, pero debe analizarse en relación con la población objeto y con las condiciones bajo las cuales se produjeron las atenciones. De esta manera, los datos utilizados permiten

establecer frecuencias que guarden correspondencia con el comportamiento observado y con las características de la población que será atendida.

6.3. Riesgo primario y riesgo técnico

En los acuerdos de voluntades, la estimación de los servicios y tecnologías en salud debe considerar los riesgos asociados a la población objeto y a la forma en que se prestan y utilizan los servicios. Estos riesgos pueden influir en las frecuencias de uso, los costos y los resultados esperados durante la ejecución del acuerdo.

El riesgo primario se relaciona con la posibilidad de que se presenten condiciones de salud o eventos que requieran atención por parte de la población objeto. Su comportamiento está relacionado con las características demográficas y epidemiológicas de la población, así como con la ocurrencia de enfermedades, condiciones de salud y otros eventos que pueden generar necesidades de atención.

El riesgo técnico, por su parte, se relaciona con las variaciones en la utilización de recursos, la ocurrencia de complicaciones o la severidad de las condiciones de salud, cuando estas se asocian con factores no previsibles en la atención o con situaciones no soportadas en la evidencia científica.

Para diferenciar estos conceptos, puede utilizarse la siguiente tabla:

Tabla 8. Diferencias entre riesgo primario y riesgo técnico

Aspecto	Riesgo primario	Riesgo técnico
Relación principal	Se relaciona con la ocurrencia de condiciones de salud en la población.	Se relaciona con la forma en que se utilizan los recursos y se prestan los servicios.
Origen	Características y condiciones de salud de la población objeto.	Factores relacionados con la prestación, utilización o gestión de la atención.
Manifestación	Aparición de enfermedades, condiciones de salud o eventos que generan necesidad de atención.	Variaciones en la utilización, complicaciones o cambios en la severidad de las condiciones de salud.
Relación con la nota técnica	Contribuye a estimar las necesidades de atención y la población susceptible.	Permite considerar variaciones que pueden afectar las frecuencias, los costos y los resultados esperados.

El riesgo técnico comprende dos componentes principales:

- **Riesgo técnico de morbilidad evitable**: corresponde a la ocurrencia de complicaciones clínicas o al aumento de la severidad de una condición de salud asociado con fallas en el modelo de prestación, la seguridad del paciente, la coordinación entre prestadores o la aplicación de guías de práctica clínica y protocolos de atención.
- **Riesgo técnico de utilización**: corresponde a la variabilidad en el uso de servicios y tecnologías en salud que no se encuentra soportada en la evidencia científica.

La consideración de estos riesgos permite comprender que las proyecciones de una nota técnica no dependen únicamente del número de personas que conforman la población objeto. También es necesario analizar las condiciones de salud de dicha población y las situaciones que pueden modificar la utilización de los servicios y tecnologías.

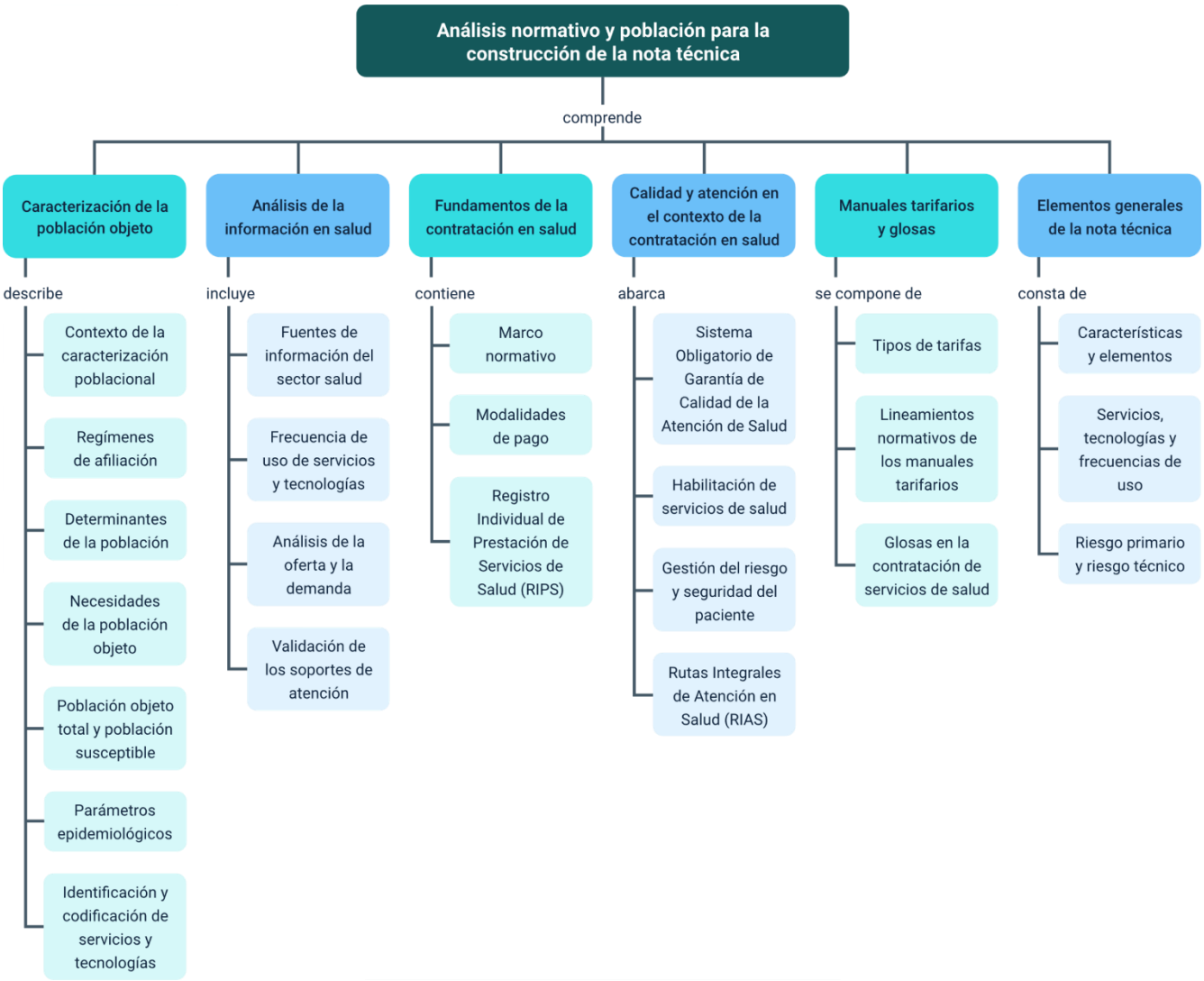
Por ejemplo, una población con una mayor presencia de determinadas condiciones de salud puede presentar una necesidad de atención superior a la estimada inicialmente. De igual manera, una complicación asociada con fallas en la prestación puede generar servicios adicionales y modificar las frecuencias y los costos proyectados.

En este sentido, el análisis del riesgo primario contribuye a establecer las necesidades esperadas de la población, mientras que el riesgo técnico permite considerar posibles variaciones relacionadas con la prestación y utilización de los

servicios. Ambos constituyen elementos que pueden incorporarse en las estimaciones y en el seguimiento de la nota técnica.

Síntesis

El componente aborda los fundamentos para la elaboración de una nota técnica en los procesos de contratación en salud, partiendo de la caracterización de la población objeto, sus regímenes de afiliación, determinantes, necesidades, parámetros epidemiológicos y población susceptible, así como de la identificación y codificación de los servicios y tecnologías requeridos. También desarrolla el análisis de las fuentes de información, las frecuencias de uso, la oferta y demanda de servicios y la validación de los soportes de atención. Además, presenta los principales elementos de la contratación en salud, su marco normativo, las modalidades de pago y el RIPS, junto con aspectos relacionados con la calidad, la habilitación, la gestión del riesgo, la seguridad del paciente y las RIAS. Finalmente, aborda los manuales tarifarios, las glosas y los elementos generales de la nota técnica, incluyendo los servicios y tecnologías, las frecuencias de uso, el riesgo primario y el riesgo técnico.


Análisis normativo y población para la construcción de la nota técnica
comprende
Caracterización de la población objeto
describe
Contexto de la caracterización poblacional
Regímenes de afiliación
Determinantes de la población
Necesidades de la población objeto
Población objeto total y población susceptible
Parámetros epidemiológicos
Identificación y codificación de servicios y tecnologías
Análisis de la información en salud
incluye
Fuentes de información del sector salud
Frecuencia de uso de servicios y tecnologías
Análisis de la oferta y la demanda
Validación de los soportes de atención
Fundamentos de la contratación en salud
contiene
Marco normativo
Modalidades de pago
Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS)
Calidad y atención en el contexto de la contratación en salud
abarca
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud
Habilitación de servicios de salud
Gestión del riesgo y seguridad del paciente
Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS)
Manuales tarifarios y glosas
se compone de
Tipos de tarifas
Lineamientos normativos de los manuales tarifarios
Glosas en la contratación de servicios de salud
Elementos generales de la nota técnica
consta de
Características y elementos
Servicios, tecnologías y frecuencias de uso
Riesgo primario y riesgo técnico

Glosario

Acuerdo de voluntades: acto mediante el cual las partes establecen las condiciones para la prestación y pago de servicios y tecnologías en salud.

Caracterización poblacional: proceso de identificación y análisis de las características, condiciones y necesidades de una población determinada.

Demanda de servicios de salud: cantidad de servicios y tecnologías en salud que son solicitados o utilizados por una población.

Frecuencia de uso: número estimado de veces que un servicio o tecnología puede ser utilizado por una población durante un periodo determinado.

Gestión del riesgo: conjunto de acciones orientadas a identificar, analizar y gestionar situaciones que pueden afectar los resultados en salud.

Glosa: objeción formulada durante la auditoría de una factura o cuenta relacionada con la prestación de servicios de salud.

Habilitación: proceso mediante el cual se verifican las condiciones que deben cumplir los prestadores para ofrecer servicios de salud.

Manual tarifario: referente que contiene valores o criterios para establecer tarifas aplicables a determinados servicios y tecnologías en salud.

Nota técnica: herramienta que integra información sobre población, servicios, tecnologías, frecuencias de uso, costos y riesgos para sustentar técnicamente un acuerdo de voluntades.

Oferta de servicios de salud: capacidad disponible para prestar servicios y tecnologías de salud, de acuerdo con los recursos y condiciones existentes.

Población susceptible: grupo de personas dentro de la población objeto que puede requerir determinados servicios o tecnologías en salud.

RIAS: rutas que organizan las intervenciones de atención en salud de acuerdo con las necesidades de las personas, familias y comunidades.

Riesgo primario: riesgo relacionado con la ocurrencia de condiciones o eventos de salud que pueden generar la necesidad de atención.

Riesgo técnico: riesgo asociado con variaciones en la utilización de servicios y tecnologías o en los recursos requeridos para la atención.

RIPS: registro que contiene información relacionada con la prestación de servicios y tecnologías en salud y que sirve como fuente para el análisis de su utilización.

Referencias bibliográficas

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). (2026). Consulta afiliados BDUA. https://servicios.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). (s. f.). Base de Datos Única de Afiliados (BDUA). https://www.adres.gov.co/eps/bdua/Paginas/afiliados-por-departamento-y-estado-de-afiliacion.aspx

Cuenta de Alto Costo. (s. f.). Cuenta de Alto Costo. https://cuentadealtocosto.org/

Instituto Nacional de Salud. (2026). SIVIGILA: Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública. https://portalsivigila.ins.gov.co/

Ministerio de Salud y Protección Social. (2017). Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS).

Ministerio de Salud y Protección Social. (2018). Resolución 3280 de 2018.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2018). Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS).

Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). Decreto 441 de 2022. https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%20No.%20441%20de%202022.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social. (2023). Resolución 2275 de 2023.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2023). Resolución 2284 de 2023.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2025). Resolución 2706 de 2025.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2024). Resolución 100 de 2024.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2024). Resolución 1885 de 2024.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2026). Facturación electrónica de venta en salud y Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS). https://www.sispro.gov.co/central-financiamiento/Pages/facturacion-electronica.aspx

Ministerio de Salud y Protección Social. (s. f.). Análisis de Situación de Salud (ASIS). https://www.minsalud.gov.co/salud/epidemiologia-demografia/Paginas/analisis-de-situacion-de-salud.aspx

Ministerio de Salud y Protección Social. (s. f.). Sistema de Información para la Calidad.

Ministerio de Salud y Protección Social. (s. f.). Sistema Integrado de Información de la Protección Social (SISPRO). https://www.sispro.gov.co/Pages/Home.aspx

Ministerio de Salud y Protección Social. (s. f.). Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud (SOGCS).

Ministerio de Salud y Protección Social. (s. f.). Sistema Único de Habilitación.

Ministerio de Salud y Protección Social. (s. f.). Sistema Único de Acreditación.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2026). Código Único de Medicamentos (CUM).

Politécnico de Colombia. (2026). Guía paso a paso: qué es el PAMEC en salud y cómo implementarlo en Colombia.

Presidencia de la República de Colombia. (1996). Decreto 2423 de 1996. Función Pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76014

Presidencia de la República de Colombia. (2016). Decreto 780 de 2016. Función Pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77813

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional G06. Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Diana Rocío Possos Beltrán	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Sandra Milena Enríquez Tróchez	Instructora experta	Centro de Comercio y Servicios - Regional Cauca
Viviana Esperanza Herrera Quiñonez	Evaluadora instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
José Jaime Luis Tang Pinzón	Diseñador de contenidos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Veimar Celis Meléndez	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Gilberto Junior Rodríguez Rodríguez	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Eduardo Rueda Peña	Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Jorge Bustos Gómez	Validador y vinculador de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima